

1. Під час профілактичного огляду пацієнта віком 69 років лікар-стоматолог виявив безболісну ерозію на червоній облямівці нижньої губи, укриту геморагічною кіркою. Ущільнення навколишніх тканин не спостерігається, регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Із анамнезу відомо: ерозія на губі не зникає вже понад рік. Установіть попередній діагноз.

- A. Хейліт Манганотті
- B. Герпетичний хейліт
- C. Первинний період сифілісу
- D. Метеорологічний хейліт
- E. Кератоакантома

2. Під час стоматологічного прийому пацієнт поскаржився на погане самопочуття. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкірного покриву, холодний піт, периферичні вени спалі, свідомість сплутана. Пульс — 130/хв, ниткоподібний, аритмічний, слабого наповнення. АТ — 80/40 мм рт. ст., дихання часте та поверхнєве. Установіть попередній діагноз.

- A. Колапс
- B. Інфаркт міокарда
- C. Анафілактичний шок
- D. Непритомність
- E. Гіпертонічний криз

3. Пацієнтці віком 39 років показано видалення 36 зуба через руйнування його біфуркації. Коронкову частину зуба видалено разом із медіальним коренем. Дистальний корінь 36 зуба зруйнований нижче рівня ясен. Який інструмент найдоцільніше застосувати для видалення дистального кореня 36 зуба?

- A. Кутовий елеватор від себе
- B. Багнетоподібні кореневі щипці
- C. Кутовий елеватор на себе
- D. Прямий елеватор
- E. Дзьобоподібні щипці, що сходяться

4. Чоловік віком 32 роки скаржиться на болючість та кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі. Ці симптоми вперше помітив 1,5 року тому, але до лікаря не звертався. Об'єктивно спостерігається: ясна обох щелеп різко гіперемовані, набряклі, болючі під час пальпації, масивні відкладення зубного каменю. На рентгенограмі патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

- A. Загострення хронічного катарального гінгівіту

- B. Хронічний катаральний гінгівіт
- C. Атрофічний гінгівіт
- D. Гіпертрофічний гінгівіт
- E. Загострення хронічного генералізованого пародонтиту

5. Пацієнт віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність крейдоподібної плями на вестибулярній поверхні 13 зуба. Установлено попередній діагноз: гострий початковий карієс 13 зуба. Яке з додаткових методів обстеження буде найінформативнішим у цьому разі?

- A. Забарвлення 2% розчином метиленового синього
- B. Електроодонтометрія
- C. Люмінесцентна діагностика
- D. Рентгенографія
- E. Холодова проба

6. Пацієнту віком 24 роки вперше діагностовано слинокам'яну хворобу з локалізацією каменя у протоці піднижньощелепної слинної залози. Виберіть найдоцільнішу тактику лікування.

- A. Видалення каменя
- B. Операція марсупіалізація
- C. Літотрипсія
- D. Видалення слинної залози
- E. Медикаментозне лікування

7. Чоловік віком 49 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігається: на нижній щелепі відсутні 46, 45, 44, 34, 35, 36 зуби. Решта зубів нижньої щелепи інтактні, стійкі, без нахилу, із добре вираженим екватором. Рекомендовано виготовлення бюгельного протеза на нижню щелепу. Який кламер показано для застосування на опорні 47 та 37 зуби в цьому разі?

- A. Аккера
- B. Бонвіля
- C. Кільцевий
- D. Роуча
- E. Зворотної дії

8. Чоловік віком 70 років скаржиться на зміщення нижньої щелепи праворуч під час відкривання рота, клацання в лівому СНЩС, незначний біль під час вживання їжі. З анамнезу відомо: поступово з'являється обмеження відкривання рота. На рентгенограмі в ділянці лівого суглобового відростка виявлено вогнище значного затемнення округлої форми з чіткими контурами, що за щільністю відповідає

кортикальній пластинці. Який попередній діагноз?

- A. Остеома
- B. Хондрома
- C. Остеїд-остеома
- D. Остеобластокластома
- E. Одонтома

9. Жінка віком 68 років скаржиться на погане загальне самопочуття, біль під час вживання їжі. Під час огляду в порожнині рота виявлено болючі ерозії яскраво- червоного кольору, що розташовані на тлі незміненої слизової оболонки. Ерозії мають нерівні краї з уривками верхніх шарів епітелію по периферії, при потягуванні за які відшаровуються видимо здорові ділянки слизової оболонки. Назвіть симптом, який перевірів лікар-стоматолог.

- A. Нікольського
- B. Хачатуряна
- C. Лукомського
- D. Мурсона
- E. Поспелова

10. Під час операції френулопластики вуздечки верхньої губи, під інфільтраційною анестезією Sol. Ultracain DS — 1,0 мл, дев'ятирічна дівчинка поскаржилася на запаморочення, нудоту, слабкість, шум у вухах і на декілька секунд втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, укрита холодним потом, дихання часте, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск — 90/60 мм рт. ст. Який найімовірніший діагноз?

- A. Непритомність
- B. Гостра серцева недостатність
- C. Гостра дихальна недостатність
- D. Анафілактичний шок
- E. Колапс

11. Під час підготовки до протезування у пацієнта віком 38 років виявлено перфорацію дна пульпової камери в ділянці біфуркації коренів 46 зуба. Об'єктивно спостерігається: 46 зуб нерухомий, пародонтальних кишень у ділянці 46 зуба не виявлено. На рентгенограмі патологічні зміни в периапікальній ділянці коренів 46 зуба не визначаються, кореневі канали запломбовані на всю довжину, у ділянці біфуркації коренів 46 зуба — невелике розрідження верхівки міжкореневої перегородки. Проведення якого виду зубозберігаючої операції показано в цьому разі?

- A. Коронаро-радикулярної сепарації

- B. Реплантації
- C. Резекції
- D. Ампутації
- E. Гемісекції

12. Пацієнтка віком 70 років із повною відсутністю зубів скаржиться на незадовільну фіксацію повного знімного протеза на нижній щелепі. З анамнезу відомо, що вона успішно користується повним знімним протезом на верхню щелепу. Під час огляду порожнини рота встановлено значну рівномірну атрофію альвеолярної частини нижньої щелепи. Прийнято рішення про дентальну імплантацію для додаткової фіксації знімного протеза на бол-абатментах. Яку мінімальну кількість імплантатів потрібно використати як опору?

- A. 2
- B. 1
- C. 4
- D. 8
- F. 6

13. Дівчина віком 19 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль у зубі на нижній щелепі ліворуч, що виникає під час вживання солодкої їжі. Об'єктивно спостерігається: у пришийковій ділянці 35 зуба пляма білого кольору з дефектом твердих тканин у межах емалі з нерівними крейдоподібними краями. Зондування чутливе. Під час вітального фарбування 2% розчином метиленового синього ділянка ураження набуває забарвлення. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий поверхневий карієс
- B. Місцева гіпоплазія
- C. Карієс у стадії білої плями
- D. Хронічний поверхневий карієс
- E. Пришийковий некроз

14. У чоловіка віком 25 років 21 зуб відсутній внаслідок травми. Пацієнту проведено операцію дентальної імплантації в цій ділянці. З метою подальшого зубного протезування отримують відбиток із верхньої щелепи методом відкритої ложки. Що з нижченаведеного треба застосувати для відтворення напрямку вісі імплантата на робочій моделі?

- A. Трансфер
- B. Абатмент
- C. Подвійний відбиток
- D. Аналог
- E. Сендвіч-техніку

15. Шестирічній дівчинці лікар-стоматолог проводить лікування гострого дифузного пульпіту 85 зуба методом вітальної екстирпації пульпи. Матеріал якої групи найдоцільніше застосувати в цьому разі для постійної obturaції корневих каналів?

- A. Цинк-евгенольні пасти
- B. Склоіономерні цементи
- C. Пасти на основі гідроксиду кальцію
- D. Пасти на основі епоксидної смоли з гутаперчевими штифтами
- F. Цинк-фосфатні цементи

16. Чоловік віком 47 років скаржиться на наявність безболісного новоутворення на нижній губі, що з'явилося місяць тому. Об'єктивно спостерігається: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи округле новоутворення 6 мм у діаметрі, підвищується над її рівнем на 2-3 мм, з гладенькою поверхнею ціанотично-червоного кольору. Під час пальпації має помірно-щільну консистенцію, без інфільтрату в основі та по периферії. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз?

- A. Бородавчастий передрак
- B. Шкірний ріг
- C. Піогенна гранульома
- D. Кератоакантома
- E. Папілома

17. Чоловіка віком 65 років госпіталізовано після ДТП у відділення щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої щелепи ліворуч. Установлено діагноз: односторонній ментальний перелом нижньої щелепи без зміщення. У пацієнта повна вторинна адентія обох щелеп. Яку шину доцільно застосувати для лікування в цьому разі?

- A. Порта
- B. Вебера
- C. Тігерштедта
- D. Ванкевич
- E. Васильєва

18. Чоловіку віком 31 рік виготовляється металокерамічний мостоподібний протез із опорою на 14 та 16 зуби. На другому лабораторному етапі зубний технік провів кінцеве шліфування та полірування каркаса, знежирення, оксидування, нанесення опаківих шарів керамічної маси та моделювання анатомічної форми зубів дентинними масами. Що забезпечує оксидування каркаса?

- A. Хімічний зв'язок із керамічними масами
- B. Очищення каркаса
- C. Механічне з'єднання з керамічними масами
- D. Міцність каркаса
- E. Дезінфекцію каркаса

19. У семирічного хлопчика під час профілактичного огляду на медіально-контактній поверхні 36 зуба лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину, що локалізована в межах навколопульпарного розм'якшеного дентину. Після препарування виникло сполучення між каріозною порожниною та пульповою камерою зуба, зондування якого супроводжується помірною кровотечею. Реакція на термічні подразники болісна, тривала. Яку лікувальну пасту треба застосувати в цьому разі?

- A. Одонтотропну
- B. Девітальну
- C. Глюкокортикостероїдну
- D. Антисептичну
- E. Антибактеріальну

20. Жінці віком 60 років виготовляються знімні протези з опорою на імпланти. Об'єктивно спостерігається: на верхній беззубій щелепі встановлено формувачі ясен. Планується отримання відбитків силіконовим матеріалом за допомогою трансферів. Яку методику відбитка треба застосувати?

- A. Відкритої ложки
- B. Розвантажувального
- C. Функціонального
- D. Компресійного
- E. Подвійного

21. Під час проведення професійної гігієни порожнини рота тринадцятирічному хлопчику у пришийковій ділянці 21 зуба лікар-стоматолог виявив ділянку емалі білого кольору, що втратила природний блиск. Поверхня емалі під час зондування гладенька та щільна. Термодіагностика негативна. Змінена ділянка емалі забарвлюється 2% водним розчином метиленового синього. Установлено діагноз: гострий початковий карієс 21 зуба, V клас за Блемом. Який метод лікування карієсу найдоцільніше застосувати в цьому разі?

- A. Інфільтрації
- B. Препарування та пломбування
- C. Імпрегнаційний
- D. ART-методику
- E. Профілактичного пломбування

22. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 43 роки зі скаргами на набряк обличчя, збільшення в об'ємі верхньої губи, язика. Ці симптоми виникли близько 40 хв тому після прийому ацетилсаліцилової кислоти. Об'єктивно спостерігається: пацієнт занепокоєний, шкірні покриви звичайного кольору, дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повік, щік, язика, м'якого піднебіння. Який імовірний діагноз?

- A.** Набряк Квінке
- B.** Синдром Мелькерсона-Розенталя
- C.** Лімфедема губ
- D.** Ексфолюативний хейліт
- E.** Контактний алергічний хейліт

23. До лікаря-стоматолога звернулися батьки шестирічного хлопчика зі скаргами на прорізування постійного зуба нижньої щелепи за тимчасовим, відсутність рухомості тимчасового зуба. Об'єктивно спостерігається: 71 зуб I ступеня рухомості, 31 зуб прорізався ріжучим краєм з язикового боку за 71 зубом. Установлено діагноз: фізіологічна зміна 71 зуба. Виберіть найдоцільніший метод знеболювання.

- A.** Інфільтраційна анестезія
- B.** Провідникова анестезія
- C.** Аплікаційна анестезія
- D.** Масковий наркоз
- E.** Внутрішньовенний наркоз

24. Чоловік віком 35 років отримав травму нижньої щелепи. Після клінічного та рентгенологічного дослідження встановлено діагноз: травматичний перелом нижньої щелепи в ділянці 34, 35 зубів зі зміщенням відламків. У пацієнта є всі зуби. Який метод лікувальної іммобілізації нижньої щелепи треба застосувати?

- A.** Двощелепне шинування з міжщелепною резиновою тягою
- B.** Накладання шини з розпірковим вигином
- C.** Металостеосинтез відламків нижньої щелепи
- D.** Накладення позаротового апарату для фіксації уламків
- E.** Однощелепне шинування з видаленням 34, 35 зубів

25. Чоловік віком 54 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення зубів, рухомість зубів на верхній та нижній щелепах. Об'єктивно спостерігається: застійна гіперемія

ясен на верхній та нижній щелепах, пародонтальні кишені глибиною до 5 мм, рухомість зубів I- II ступенів. На ортопантомограмі виявлено резорбцію альвеолярних відростків щелеп у межах 1/2 довжини коренів зубів. Установіть діагноз.

- A.** Генералізований пародонтит, II ступінь, Хронічний перебіг
- B.** Генералізований пародонтит, I ступінь, загострення
- C.** Генералізований пародонтит, II ступінь, загострення
- D.** Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг
- E.** Генералізований пародонтит, I ступінь, загострення

26. Під час огляду пацієнта віком 58 років лікар-стоматолог виявив деформацію та зменшення в розмірах язика, що має синюшно-червоний колір та щільну структуру. На слизовій оболонці піднебіння спостерігається гумозна інфільтрація. Установіть попередній діагноз.

- A.** Третинний період сифілісу
- B.** Десквамативний глосит
- C.** Складчастий язик
- D.** Вроджена аномалія язика
- E.** Ромбоподібний глосит

27. Чоловік віком 24 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен. Об'єктивно спостерігається: ясенні сосочки в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи застійно гіперемовані з незначним набряком, наявні мінералізовані та немінералізовані зубні відкладення. Виявлено рухомість нижніх центральних різців I ступеня. Який із нижченаведених місцевих факторів може сприяти виникненню локалізованого пародонтиту?

- A.** Глибина присінку 8 мм
- B.** Ортогнатичний прикус
- C.** Некаріозні ураження зубів
- D.** Коротка вуздечка нижньої губи
- E.** Біпрогнатія

28. Пацієнту виготовляються повні знімні пластинкові протези для верхньої та нижньої щелеп. Як називається сагітальна оклюзійна крива нижньої щелепи, відновлення якої забезпечить безперешкодне виконання жувальних рухів нижньої щелепи?

- A.** Шпее

- B.** Гізі
- C.** Бонвіля
- D.** Уїлсона
- E.** Ганау

29. Пацієнту віком 57 років із відсутністю бічних зубів на верхній щелепі виготовляють частковий знімний пластинковий протез. Прикус за ортогнатичним типом. На яку висоту з піднебінного боку базис протезу має перекривати коронки фронтальних зубів?

- A.** На 1/3 висоти коронки
- B.** На 1/2 висоти коронки
- C.** На 2/3 висоти коронки
- D.** На всю висоту коронки
- E.** До рівня шийок

30. Чоловік віком 38 років скаржиться на наявність новоутворення овальної форми, розміром 3x5 см на передньо-боковій поверхні ший ліворуч, що з'явилося близько 2-х років тому. Об'єктивно спостерігається: утворення рухоме, безболісне, м'якоеластичне, із чіткими межами, шкіра над ним звичайного кольору, береться у складку. Якому захворюванню відповідають ці клінічні симптоми?

- A.** Ліпомі
- B.** Нейрофіброматозу II типу
- C.** М'який фібромі
- D.** Лейоміомі
- E.** Хворобі Маделунга

31. Пацієнт під час видалення 26 зуба після проведення туберальної анестезії відчув набряк слизової оболонки ротоглотки, утруднене дихання, за грудничний біль, недостатність повітря, слабкість, головний біль, задишку, тахікардію. Стан швидко погіршується, дихання поверхневе, часте, шкіра бліда, холодна, липкий піт, пульс — 100/хв, АТ — 60/40 мм рт.ст. Який імовірний діагноз?

- A.** Анафілактичний шок
- B.** Ішемічна хвороба серця
- C.** Гостра кропив'янка
- D.** Напад бронхіальної астми
- E.** Ангіоневротичний набряк

32. Дванадцятирічний хлопчик скаржиться на загальну слабкість, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно спостерігається: різка гіперемія задньої стінки глотки та піднебінних мигдаликів, частина яких вкрита жовтувато-сірим нальотом, що легко знімається. Слизова оболонка порожнини рота набрякла, у ділянці щік наявні геморагії у

вигляді петехій, язик вкритий нальотом. Під час пальпації виявлено збільшення підщелепних та шийних лімфатичних вузлів, які мало болючі та рухомі з колатеральним набряком без ознак запалення на шкірі. Результат аналізу крові: лейко-, лімфо- і моноцитоз, атипові мононуклеари (до 25-30%). Якому захворюванню притаманні ці симптоми?

- A.** Інфекційний мононуклеоз
- B.** Вітряна віспа
- C.** Оперізувальний лишай
- D.** Кір
- E.** Скарлатина

33. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль у ділянці фронтальних верхніх зубів під час вживання холодної їжі, що з'явився тиждень тому після травми. Під час огляду виявлено: відсутній медіальний кут коронки 21 зуба, відлом різального краю 11 зуба в межах плащового дентину. Зондування 11, 21 зубів слабо болісне, реакція на холодний подразник болісна, короткотривала. ЕОД — 7 мкА. Який пломбувальний матеріал доцільно використати під час лікування?

- A.** Мікрогібридний композит
- B.** Амальгаму
- C.** Склоіономерний цемент
- D.** Макронаповнений композит
- E.** Компомер

34. На прийом до лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 29 років зі скаргами на різкий пульсуючий біль у зубах верхньої щелепи з правого боку, що турбує третій день та поступово наростає. Зі слів пацієнта, біль нестерпний, майже безперервний, його інтенсивність дещо зменшується під час уживання холодної води. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 17 зуба глибока каріозна порожнина, заповнена великою кількістю розм'якшеного та слабо пігментованого дентину. Перкусія 17 зуба болісна. ЕОД — 35 мкА. Який імовірний діагноз?

- A.** Гострий гнійний пульпіт
- B.** Загострення хронічного пульпіту
- C.** Гострий гнійний періодонтит
- D.** Гострий дифузний пульпіт
- E.** Гострий серозний періодонтит

35. Батьки дванадцятирічної дівчинки скаржаться на наявність у дитини сухості та лущення губ, тріщин у кутах рота. З анамнезу відомо: алергічні реакції на харчові продукти та

побутовий пил. Об'єктивно спостерігається: червона облямівка губ інфільтрована, суха, вкрита лусочками та численними тонкими борозенками. Прилегла шкіра ущільнена, дещо пігментована, суха з ознаками лущення, судинний малюнок посилений, у кутах рота наявні тріщинки. Який вид хейліту, найімовірніше, виявлено в дитини?

- А. Атопічний
- В. Ексфоліативний
- С. Метеорологічний
- Д. Контактний алергійний
- Е. Екзематозний

36. Жінка віком 30 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємне відчуття розпирання в зубі верхньої щелепи праворуч, що посилюється від гарячого. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 17 зуба глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою. Глибоке зондування болісне, перкусія 17 зуба слабкоболісна. На рентгенограмі виявлено незначне розширення періодонтальної щілини на верхівках коренів. ЕОД — 70 мкА. Який імовірний діагноз?

- А. Хронічний гангренозний пульпіт
- В. Хронічний фіброзний пульпіт
- С. Хронічний фіброзний періодонтит
- Д. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
- Е. Гострий гнійний пульпіт

37. Пацієнту віком 53 роки діагностовано перелом нижньої щелепи у фронтальній ділянці без зміщення. Об'єктивно спостерігається: на верхній щелепі незнімні ортопедичні конструкції, на нижній щелепі відсутня бічна група зубів із обох боків, зуби від ікла до ікла інтактні. Виберіть шину для лікування в цьому клінічному випадку.

- А. Шина Ванкевич
- В. Шина Васильєва
- С. Лігатурне зв'язування по Айві
- Д. Шина Порта
- Е. Шина Лімберга

38. В одинадцятирічного хлопчика визначається потовщення нижньої щелепи у фронтальному відділі, що з'явилося після травми в результаті падіння місяць тому. Об'єктивно спостерігається: на нижній щелепі в ділянці перехідної складки є обмежена ущільнена ділянка, поверхня якої гладенька, незначно болюча під час пальпації. Зуби, що

локалізовані в ділянці патологічного вогнища, інтактні та вітальні. На рентгенограмі у фронтальному відділі нижньої щелепи виявлено вогнище остеопорузу з потовщенням окістя. Який імовірний діагноз?

- А. Рарефікуючий періостит
- В. Хронічний остеомієліт, деструктивно-продуктивна форма
- С. Деформуючий остеїт
- Д. Хронічний остеомієліт, деструктивна форма
- Е. Хронічний гранулематозний періодонтит

39. Юнак віком 17 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на відсутність зуба на верхній щелепі, естетичний дефект. Під час огляду виявлено відсутність 12 зуба; 11, 13 зуби інтактні, паралельні, стійкі, прикус ортогнатичний. З анамнезу відомо: 12 зуб видалено півроку тому через травму. Який вид протезування найдоцільніше застосувати в цьому разі?

- А. Адгезивний мостоподібний протез
- В. Суцільнокерамічний мостоподібний протез з опорою на 11, 13 зуби
- С. Бюгельний протез
- Д. Консольний мостоподібний протез з опорою на 13 зуб
- Е. Металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 11, 13 зуби

40. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на відсутність прорізування в дитини переднього зуба верхньої щелепи. Під час огляду на вестибулярній поверхні в ділянці відсутнього 11 зуба виявлено незначне вибухання тканин альвеолярного відростка. На рентгенограмі визначається тінь високої інтенсивності з чіткими нерівними контурами, на тлі якої розташовані множинні, різної форми та величини зубоподібні утворення, а по периферії — смуга розрідження кісткової тканини та обідок склерозу на межі зі здоровими тканинами. Який найімовірніший діагноз?

- А. Адамантинома верхньої щелепи
- В. Одонтогенна фіброма верхньої щелепи
- С. Радикулярна кіста верхньої щелепи від 11 зуба
- Д. Фолікулярна кіста верхньої щелепи від 11 зуба
- Е. Одонтома верхньої щелепи

41. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на періодично виникаючий біль у ділянці кута нижньої щелепи

з правого боку та утруднене відкривання рота. Показано видалення 48 зуба. Виберіть щипці, якими треба провести видалення.

- А. Зігнуті за площиною
- В. Дзьобоподібні зі щічками, що не сходяться
- С. Дзьобоподібні зі щічками, що сходяться
- Д. Дзьобоподібні з шипами на щічках
- Е. Багнетоподібні

42. Пацієнту віком 38 років лікар-стоматолог проводить лікування гострого дифузного пульпіту 36 зуба методом вітальної екстирпації. Після етапу інструментальної та медикаментозної обробки лікар переходить до етапу пломбування кореневих каналів. Які штифти можна використати як філер?

- А. Гутаперчеві
- В. Паперові
- С. Скловолоконні
- Д. Парапульпарні
- Е. Анкерні

43. Пацієнту з діагнозом гострий гнійний одонтогенний періостит від 36 зуба лікар-стоматолог-хірург проводить операцію періостотомії. Укажіть місце та довжину проведення розтину.

- А. Перехідна складка у ділянці 36 зуба
- В. Ясенний край протягом трьох зубів
- С. Зовнішньоротовий піднижньощелепний розтин
- Д. Точковий розтин у місці найбільшого вибухання інфільтрату
- Е. Перехідна складка протягом трьох зубів

44. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 24 роки у терміні вагітності 22 тижні зі скаргами на гострий біль у ділянці 38 зуба. Алергологічний анамнез не обтяжений. Об'єктивно спостерігається: коронка 38 зуба зруйнована на 2/3, перкусія різко болісна. Показано видалення зуба. Який анестетик із нижченаведених є препаратом вибору для вагітних пацієнток?

- А. Артикаїн
- В. Лідокаїн
- С. Новокаїн
- Д. Мепівакаїн
- Е. Бупівакаїн

45. Пацієнту лікар-стоматолог-ортопед виготовляє вкладку на 36 зуб непрямым методом. У зубі сформовано порожнину під вкладку. Який наступний етап?

- А. Зняття відбитків — робочого, допоміжного та оклюзійного
- В. Фіксація вкладки
- С. Литво
- Д. Моделювання вкладки воском на моделі
- Е. Моделювання вкладки воском у ротовій порожнині

46. Жінці віком 41 рік виготовляється металокерамічний мостоподібний протез у фронтальній ділянці верхньої щелепи через вторинну адентію 12, 11, 21 зубів. Яку форму проміжної частини доцільно виготовити?

- А. Дотичну
- В. Сідлоподібну
- С. Сідлоподібну з облицюванням видимих поверхонь
- Д. Комбіновану
- Е. Промивну

47. На рентгенограмі 11 зуба семирічної дівчинки спостерігається: стінки кореня проєктуються, як дві смуги щільної тіні, що поступово стоншуються та розходяться в напрямку зони росту, кореневий канал має вигляд лійки, його розширена частина зливається з ділянкою просвітлення округлої форми, чітко обмеженої тонкою смужкою щільної тіні у вигляді півкола. Яку стадію формування кореня виявлено в цьому разі?

- А. Несформованої верхівки кореня
- В. Сформованого кореня та періодонту
- С. Несформованого періодонту
- Д. Незакритої верхівки кореня
- Е. Росту кореня в довжину

48. Батьки шестирічної дівчинки скаржаться на різке підвищення температури тіла в дитини, погіршення загального самопочуття, порушення сну, біль та набряк у привушній ділянці праворуч. Об'єктивно спостерігається: гіперемія слизової оболонки навколо вустя вивідної протоки правої привушної слинної залози, біль під час пальпації попереду козелка вуха та в ділянці кута нижньої щелепи з правого боку. Під час масажування слинної залози з протоки виділяється дуже мала кількість в'язкої прозорої слини. Установіть попередній діагноз.

- А. Епідемічний паротит
- В. Хронічний паренхіматозний сіалоаденіт
- С. Псевдопаротит Герценберга
- Д. Гострий бактеріальний паротит
- Е. Калькульозний сіалоаденіт

49. Дванадцятирічна дівчина скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 39,5°C, болючу, пульсуючу припухлість у підборідній ділянці, що з'явилася після видавлювання гноячка. Об'єктивно спостерігається: розлитий болісний щільний інфільтрат у підборідній ділянці, у центрі якого велика зона некрозу тканин із кількома осередками виділення гнійного ексудату. Шкірний покрив інших ділянок обличчя — без видимих патологічних змін. Виражені симптоми загальної інтоксикації, регіонарні лімфовузли збільшені. Який найімовірніший діагноз?

- A. Карбункул
- B. Демодекоз
- C. Абсцес
- D. Флегмона
- E. Фурункул

50. У жінки віком 62 роки знижена висота прикусу, що призводить до тиску голівок нижньої щелепи на склепіння суглобової ямки, вушно-темпоральний нерв та барабанну струну. До якої хвороби може призвести ця клінічна ситуація?

- A. Синдрому Костена
- B. Внутрішньосуглобового анкілозу
- C. Артрогенної контрактури нижньої щелепи
- D. Ювенільної дисфункції СНЩС

Синдрому Робена

51. Під час аналізу складу питної води в регіоні виявлено, що концентрація фтору в ній становить 0,5 мг/л. Яке захворювання твердих тканин зубів можна прогнозувати?

- A. Карієс
- B. Некроз твердих тканин зубів
- C. Флюороз
- D. Системна гіоплазія емалі
- E. Ерозія твердих тканин зубів

52. Дівчина віком 16 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на потемніння коронок 11 та 12 зубів. Зі слів пацієнтки, близько року тому в неї була спортивна травма. Об'єктивно спостерігається: коронки 11 та 12 зубів темно-сірого кольору, інтактні, під час перкусії безболісні. Слизова оболонка альвеолярного відростка не змінена. На рентгенограмі у ділянці верхівок коренів 11 та 12 зубів виявлено ділянки деструкції кісткової тканини округлої форми, розміром 0,3-0,4 см у діаметрі, із чіткими межами. Якою має бути тактика лікаря-стоматолога стосовно 11, 12 зубів пацієнтки?

- A. Ендодонтичне лікування
- B. Естетична реставрація
- C. Ендодонтичне та хірургічне лікування
- D. Видалення
- E. Спостереження протягом 6 місяців

53. Що дозволяє визначити вивчення моделей щелеп у період постійного прикусу за Коркгаузом?

- A. Довжину переднього відрізка верхнього та нижнього зубних рядів у сагітальному напрямку
- B. Розміри зубних рядів у трансверзальній площині
- C. Співвідношення ширини поперечних розмірів верхніх та нижніх різців
- D. Невідповідність розташування бічних зубів у зубному ряді в сагітальному та трансверзальному напрямках
- E. Лонгітудинальну довжину зубних рядів

54. У результаті чого утворюються смуги Гунтера-Шрегера на поздовжніх шліфах емалі?

- A. Чергування поздовжніх та поперечних зрізів емалевих призм
- B. Неоднорідності розміщення емалених пучків
- C. Неоднорідності мінералізації емалевих призм
- D. Мінералізації міжпризматичних проміжків
- E. Циклічних порушень у формуванні емалевих призм

55. Оловик віком 38 років скаржиться на ниючий біль у ділянці зуба нижньої щелепи праворуч упродовж двох діб. Об'єктивно спостерігається: на дистальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина в межах припульпарного дентину, зондування дна безболісне, вертикальна перкусія позитивна, термопроба негативна. Слизова оболонка в ділянці проєкції верхівок коренів 46 зуба гіперемована. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий серозний періодонтит
- B. Загострення локалізованого пародонтиту
- C. Загострення хронічного пульпіту
- D. Гострий гнійний періодонтит
- E. Гострий гнійний пульпіт

56. Пацієнту віком 70 років з повною відсутністю зубів на обох щелепах та різко вираженою прогенією лікар-стоматолог виготовляє повні знімні протези. Які штучні зуби не виставляються у протезах за цих клінічних умов?

- A. На верхній щелепі — другі премоляри
- B. На верхній щелепі — другі моляри
- C. На верхній щелепі — перші премоляри
- D. На нижній щелепі — другі моляри
- E. На нижній щелепі — перші премоляри

57. До лікаря-стоматолога звернулися батьки чотирирічної дівчинки для профілактичного огляду дитини. В анамнезі наявність чинників високого рівня розвитку карієсу. Яку методику дослідження доцільно рекомендувати з метою виявлення початкових ознак карієсу контактних поверхонь зубів?

- A. Прицільну рентгенографію
- B. Термодіагностику
- C. Зондування
- D. Ортопантомографію
- E. Інтерпроксимальну рентгенографію

58. Батьки семирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта для профілактичного огляду дитини. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, нижня третина обличчя подовжена, спинка носа широка, червона облямівка губ суха. При зімкненні губ визначається напруження, точкові поглиблення в ділянці підборіддя. Крила носа нерухомі. Про порушення якої функції свідчать лицеві ознаки в цього пацієнта?

- A. Дихання
- B. Жування
- C. Смоктання
- D. Мовлення

59. Пацієнт віком 49 років скаржиться на кровоточивість, свербіж та болючість ясен. Об'єктивно спостерігається: ясна яскраво-червоного кольору, набряклі, під час пальпації з пародонтальних кишень виділяється серозно-гнійний екссудат, рухомість окремих зубів I ступеня. Які зміни в клінічному аналізі крові характерні для такого перебігу захворювання?

- A. Нейтрофільний зсув вліво, підвищення ШОЕ
- B. Нейтрофільний зсув вліво, тромбоцитопенія
- C. Нейтрофільний зсув вліво, поліцитемія
- D. Нейтрофільний зсув вправо, підвищення ШОЕ
- E. Нейтрофільний зсув вліво, зниження ШОЕ

60. Чоловік віком 20 років на третій день від початку захворювання на ларингіт відчув посилення болю під час ковтання, відчуття стороннього тіла, зміну голосу, задишку. Після проведеного консервативного лікування стан

пацієнта продовжував погіршуватися. З'явився грубий кашель, утруднене гортанне дихання, підвищення температури тіла до 39°C. Після проведення ларингоскопічного дослідження пацієнту діагностовано асфіксію внаслідок стенозу гортані. Яка невідкладна допомога в цьому разі?

- A. Інтубація трахеї
- B. Призначення антибіотиків широкого спектра дії
- C. Дегідратаційна терапія
- D. Призначення антигістамінних препаратів
- E. Призначення кортикостероїдів

61. Чоловік віком 42 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на підвищену чутливість зубів під час їх чищення та від дії термічних і хімічних подразників. Об'єктивно спостерігається: у пришийкових ділянках 45, 44, 43, 33, 34, 35 зубів дефекти твердих тканин у межах плащового дентину з гладкими стінками, що сходяться під кутом. Установіть діагноз.

- A. Клиноподібні дефекти
- B. Патологічне стирання зубів
- C. Некроз емалі
- D. Гіперестезія зубів
- E. Ерозія емалі

62. Чоловік віком 63 роки звернувся до лікаря-стоматолога через 5 днів після фіксації часткового знімного пластинкового протеза зі скаргами на біль та виникнення дефектів на слизовій оболонці порожнини рота. Що є причиною появи виразок на слизовій оболонці біля країв базису протеза?

- A. Механічна травма слизової оболонки краєм базису
- B. Неправильне розміщення кламерів
- C. Помилки під час вибору штучних зубів
- D. Вживання грубої їжі
- E. Погана фіксація протеза

63. Чоловік віком 19 років скаржиться на появу безболісного кулькоподібного утворення на бічній поверхні шиї. Загальний стан пацієнта не змінений. Об'єктивно спостерігається: попереду грудинно-ключично-соскоподібного м'язу на межі верхньої та середньої його третин рухоме новоутворення щільноеластичної консистенції, шкіра над яким не змінена. Порожнина рота санована. У пунктаті виявлено кристали холестерину.

- A. Бічна кіста шиї
- B. Гострий серозний лімфаденіт

- С. Установіть діагноз.
- Д. Ліпома бічної поверхні шиї
- Е. Атерома бічної поверхні шиї F. о D.
Хронічний лімфаденіт

64. Чоловік віком 56 років скаржиться на незвичний вигляд язика та інколи відчуття печіння в ньому. Під час огляду на язиці виявлено обмежені ділянки десквамації епітелію червоно-рожевого кольору. Навколо осередків ураження — незначний кератоз. Зі слів пацієнта, його часто турбують болі в шлунку. Установіть діагноз.

- А. Десквамативний глосит
- В. Ромбоподібний глосит
- С. Невралгія язика
- Д. Складчастий язик
- Е. Волосатий язик

65. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття «скутості» у грудній клітці. У пацієнтки спостерігається свистяче дихання з подовженим видихом та кашель. З анамнезу відомо, що такі симптоми виникають після попереднього контакту з алергенами чи повітряними іритантами. Який невідкладний стан виник у пацієнтки?

- А. Напад бронхіальної астми
- В. Алергічний риніт
- С. Гостра дихальна недостатність
- Д. Гостра серцева недостатність
- Е. Хронічне обструктивне захворювання легенів, загострення

66. Пацієнту віком 67 років виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелепи. Для постановки штучних зубів проводиться запис рухів нижньої щелепи. Який середній кут сагітального суглобового шляху?

- А. 33°
- В. 17°
- С. 110°
- Д. 12°
- Е. 63°

67. Ікар-стоматолог під час санації ротової порожнини пацієнта віком 18 років звернув увагу на наявність великих гематом на шкірі верхніх кінцівок. Пацієнт розповів, що є також гематоми в ділянці живота та нижніх кінцівок, а також періодично виникають крововиливи в суглоби. З анамнезу відомо, що з дитинства в пацієнта виникають тривалі кровотечі внаслідок травм та порізів. Яке обстеження буде

найінформативнішим для встановлення діагнозу?

- А. Коагулограма, вміст VIII, IX, XI чинників згортання у плазмі крові
- В. Електроліти крові
- С. Загальний аналіз крові
- Д. Глікований гемоглобін
- Е. Аналіз крові на глюкозу

68. Пацієнту віком 54 роки планується виготовлення бюгельного протеза для верхньої щелепи. Робочий відбиток знято силіконовим, а допоміжний — альгінатним відбитковим матеріалом. Скільки моделей треба відлити для виготовлення одного бюгельного протеза?

- А. Дві робочі й одну допоміжну
- В. Одну робочу та дві допоміжні
- С. Дві робочі та дві допоміжні
- Д. Одну робочу й одну допоміжну
- Е. Одну робочу модель

69. Чоловік віком 44 роки скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 38°C, наявність припухлості під нижньою щелепою ліворуч. З анамнезу відомо, що останній тиждень пацієнта турбував біль у ділянці 36 зуба. Об'єктивно спостерігається: у лівій піднижньощелепній ділянці збільшений болісний вузол, шкіра над ним гіперемована та напружена, у складку не береться. У порожнині рота частково зруйнований 36 зуб. Установіть імовірний діагноз.

- А. Гострий гнійний лімфаденіт
- В. Гострий серозний лімфаденіт
- С. Фурункул
- Д. Абсцес піднижньощелепної ділянки
- Е. Хронічний лімфаденіт

70. У пацієнтки після перенесеного комбінованого лікування з приводу раку нижньої губи встановлено діагноз: остеорадіонекроз нижньої щелепи. Чим може бути зумовлений розвиток цього захворювання?

- А. Проведенням променевої терапії
- В. Незбалансованим харчуванням
- С. Метастазуванням пухлини
- Д. Ускладненням хірургічного втручання
- Е. Рецидивом злоякісної пухлини

71. У пацієнта віком 43 роки після видалення 26 зуба виникло сполучення з верхньощелепною пазухою. Рентгенологічних змін у верхньощелепних пазухах не виявлено.

Якою буде тактика лікаря-стоматолога-хірурга для профілактики виникнення гаймориту?

- A. Пластичне закриття сполучення
- B. Тампонада лунки йодоформною турундою
- C. Заповнення лунки гемостатичною губкою
- D. Промивання пазухи розчином антибіотика
- E. Заповнення лунки кров'яним згустком

72. Пацієнтка віком 70 років скаржиться на скидування верхнього повного знімного протеза під час жування. Користується повними знімними протезами на обидві щелепи протягом місяця. Під час проведення пальцевих проб встановлено наявність замикальних клапанів на обох протезах. У фронтальній ділянці передні зуби верхнього протеза перекривають передні зуби нижнього на одну третину, контакт між бічними зубами — множинний рівномірний фісурно-горбковий. Що дозволить покращити фіксацію верхнього протеза?

- A. Розширення меж базису протеза
- B. Вкорочення передніх зубів на верхньому протезі
- C. Пришліфування бічних зубів
- D. Корекція краю протеза
- E. Укорочення передніх зубів на нижньому протезі

73. Сума поперечних розмірів яких зубів лежить в основі побудови діаграми Хаулея-Гербера-Гербста та взята за радіус АВ?

- A. 11, 12, 13 зубів
- B. 11, 12, 21, 22 зубів
- C. 51, 52, 61, 62 зубів
- D. 31, 32, 41, 42 зубів
- E. 31, 32, 33 зубів

74. Батьки семирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини. Під час огляду в обмеженій ділянці фісури 46 зуба виявлено каріозну порожнину невеликих розмірів із вузьким вхідним отвором. Зонд застрягає у розм'якшеному плащовому дентині. Виберіть оптимальну лікувальну тактику в цьому разі.

- A. Профілактичне пломбування
- B. Глибоке фторування
- C. Неінвазивна герметизація
- D. Інвазивна герметизація
- E. Метод імпрегнації

75. Хлопець віком 16 років скаржиться на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 37,8°C, біль під час ковтання. Об'єктивно спостерігається: катаральний гінгівіт, запальні

зміни в ділянці зів, піднебінних дужок та язичка, набряк мигдаликів, що вкриті масивним фібринозним нальотом, який щільно спаяний із підлеглими тканинами та поширюється на м'яке та тверде піднебіння. Після зняття фібринозного нальоту оголюється ерозивна поверхня. Визначте ймовірного збудника цього захворювання.

- A. Паличка Лефлера
- B. Вірус простого герпесу
- C. Гемолітичний стрептокок
- D. Вірус Епштейна-Барр
- E. Вірус Коксаки

76. Чоловік віком 29 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичну ваду у вигляді пігментованої плями на фронтальному зубі верхньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: 21 зуб дещо повернутий за віссю, на контактено-медіальній поверхні наявна коричнева пляма з чіткими межами. Під час зондування поверхня плями дещо шорстка. Больова реакція на температурний подразник не виникає. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний початковий карієс
- B. Місцева гіпоплазія емалі
- C. Ендемічний флюороз
- D. Некроз емалі
- E. Хронічний поверхневий карієс

77. Батьки тримісячного хлопчика звернулися до дитячого лікаря-стоматолога зі скаргами на появу в ротовій порожнині дитини нальоту білого кольору. Хлопчик неспокійний, вередує під час годування. Об'єктивно спостерігається: на набряклій та гіперемованій слизовій оболонці щік та на спинці язика білуватий наліт, що легко знімається без пошкодження цілісності слизової оболонки. Виберіть засоби для етіотропного лікування цього захворювання.

- A. Протигрибкові
- B. Противірусні
- C. Антибактеріальні
- D. Антигістамінні
- E. Протиааеробні

78. На етапі фіксації часткового знімного пластинкового протеза лікар-стоматолог виявив крейдоподібні смуги та плями на поверхні протеза. Унаслідок чого виникають ці недоліки?

- A. Недостатньої кількості мономеру
- B. Різкого охолодження під час полімеризації

- С. Різкого підвищення температури на етапі полімеризації
- Д. Недостатнього стискання частин кювети
- Е. Неякісного полірування поверхні протеза

79. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта для профілактичного огляду. Об'єктивно спостерігається: нижня губа виступає, форма верхнього зубного ряду трапецієвидна, нижнього — відповідає нормі. Між верхніми та нижніми передніми зубами сагітальна щілина 2 мм, перші постійні моляри змикаються за III класом Енгля. Який апарат використовують для лікування цієї патології прикусу?

- А. Регулятор функції Френкля III типу
- В. Брекет-систему
- С. Пропульсор Мюлемана
- Д. Регулятор функції Френкля I типу
- Е. Пластинку Шонхера

80. Жінка віком 38 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну вигляду червоної облямівки нижньої губи. Під час огляду на шкірі носа та обох щік виявлено еритематозні плями з осередками гіперкератоза. На червоній облямівці нижньої губи спостерігаються еритематозні плями з ділянками атрофії в центрі, які вкриті лусочками по периферії. З анамнезу відомо, що в пацієнтки хронічний поліартрит. Установіть попередній діагноз.

- А. Червоний вовчак
- В. Червоний плоский лишай
- С. Герпетичний стоматит
- Д. Актинічний хейліт
- Е. Хейліт Манганотті

81. Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, рухомість зубів та оголення їхніх шийок. На етапі огляду проводилося вимірювання глибини пародонтальних кишень та визначення ступеня залучення в пародонтальну кишеню біфуркації коренів зубів. Скільки існує класів ступеня залучення в пародонтальну кишеню біфуркації?

- А. Три
- В. П'ять
- С. Чотири
- Д. Один
- Е. Два

82. Жінка віком 52 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці

нижнього переднього зуба. Об'єктивно спостерігається: наявні 33, 32, 31, 41, 42, 43 зуби, пацієнтка користується частковим знімним пластинковим протезом протягом року, фіксується протез добре. Установлено діагноз: загострення хронічного періодонтиту 42 зуба та проведено його видалення. Яка тактика лікаря щодо подальшого протезування пацієнтки?

- А. Провести реконструкцію часткового знімного пластинкового протеза методом приварки штучного зуба
- В. Рекомендувати використовувати протез далі
- С. Виготовити новий частковий знімний пластинковий протез
- Д. Провести пряме перебазування протеза
- Е. Провести непряме перебазування протеза

83. Чоловік віком 43 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на розцементування металокерамічного мостоподібного протеза на нижній щелепі з опорою на 33, 36 зуби. Об'єктивно спостерігається: опорні зуби відновлені композитним матеріалом, без патологічних змін твердих тканин, величина коронкових частин зубів — середня, конусність апроксимальних поверхонь 30°, рельєф оклюзійних поверхонь збережено. Яка найімовірніша причина розцементування конструкції в цьому разі?

- А. Значне збільшення конусності апроксимальних поверхонь опорних зубів
- В. Неправильний вибір конструкції
- С. Збережений рельєф жувальної поверхні опорних зубів
- Д. Неправильний вибір матеріалу для відновлення опорних зубів
- Е. Наявність вторинного карієсу в опорних зубах

84. Чоловік віком 47 років скаржиться на часткову відсутність передніх зубів на верхній щелепі. З анамнезу відомо, що зуби втрачені внаслідок травми 3 місяці тому. Об'єктивно спостерігається: 11, 12 зуби відсутні, 13, 21, 22 зруйновані на 2/3, відновлені пломбами. Прикус ортогнатичний. Яку конструкцію протеза найдоцільніше застосувати в цьому разі?

- А. Металокерамічний мостоподібний протез
- В. Бюгельний протез із фіксацією на атачменах
- С. Пластмасовий мостоподібний протез
- Д. Частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу
- Е. Адгезивний мостоподібний протез

85. Чоловік віком 46 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровоточивість у ділянці верхнього зуба праворуч під час вживання їжі або чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 16 зуба глибока каріозна порожнина виповнена грануляційною тканиною. Поверхнєве зондування каріозної порожнини безболісне, глибоке — болісне, перкусія 16 зуба безболісна, ЕОД — 40 мкА. Який імовірний діагноз?

- A. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- B. Хронічний грануляційний періодонтит
- C. Хронічний конкрементозний пульпіт
- D. Хронічний катаральний гінгівіт
- E. Хронічний гангренозний пульпіт

86. Які риси притаманні першому типу діастеми за класифікацією Ф.Я. Хорошилкиної?

- A. Латеральне відхилення коронок центральних різців за умови правильного положення верхівок їхніх коренів
- B. Медіальний нахил коронок центральних різців та латеральне відхилення їх коренів
- C. Асиметричне зміщення центральних різців
- D. Корпусне латеральне зміщення різців
- E. Супрапозиція центральних різців

87. Дворічна дівчинка хворіє протягом трьох днів, відмовляється від їжі. Об'єктивно спостерігається: температура тіла 38,5°C, на слизовій оболонці м'якого та твердого піднебіння є 4-6 дрібних ерозій овальної форми з тонкою червоною облямівкою, укритих фібринозним нальотом. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Відзначається набряк, гіперемія та кровоточивість ясен. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий герпетичний стоматит
- B. Гострий кандидозний стоматит
- C. Герпетична ангіна
- D. Інфекційний мононуклеоз
- E. Багатоформна ексудативна еритема

88. Під час огляду десятирічного хлопчика лікар-стоматолог-ортодонт провів клінічний тест за Ешлером-Бітнером для диференціальної діагностики дистального прикусу. Форма обличчя погіршується. Яка причина аномалії оклюзії за результатами цього тесту?

- A. Порушення розмірів верхньої щелепи
- B. (не вказано)
- C. Недостатній розвиток нижньої щелепи
- D. Порушення росту та розвитку обох щелеп

E. Надмірний розвиток нижньої щелепи

89. Чоловік віком 38 років скаржиться на постійний біль у ділянці нижньої щелепи з правого боку, що іррадіює в сусідні ділянки, підвищення температури тіла до 40°C. Об'єктивно спостерігається: набряк м'яких тканин навколо тіла нижньої щелепи праворуч, шкіра гіперемована. Відкривання рота обмежене, слизова оболонка порожнини рота набрякла та гіперемована з обох боків альвеолярного відростка в ділянці 45, 46, 47 зубів. Коронка 46 зуба зруйнована повністю. Перкусія 45, 46, 47 зубів болісна, зуби рухомі. Установіть попередній діагноз.

- A. Гострий одонтогенний остеомієліт
- B. Загострення хронічного періодонтиту 46 зуба
- C. Одонтогенний абсцес піднижньощелепної ділянки праворуч
- D. Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт
- E. Гострий одонтогенний періостит

90. Жінка віком 53 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відсутність бічних зубів нижньої щелепи, утруднене пережовування їжі, рухомість наявних зубів, кровоточивість ясен. Об'єктивно спостерігається: ясна обох щелеп мають ціанотичний відтінок, кровоточать під час зондування, відсутні 35, 36, 45, 46 зуби, коронки 34, 37, 44, 47 зубів високі, мають рухомість I ступеня. На ортопантограмі виявлено резорбцію міжзубних перетинок обох щелеп у межах 1/3 їх висоти. Застосування якої конструкції найдоцільніше в цьому разі?

- A. Бюгельного протеза з елементами шинування
- B. Штамповано-паяних мостоподібних протезів з опорою на 34, 37, 44, 47 зуби
- C. (не вказано)
- D. Часткового знімного пластинкового протеза
- E. Металокерамічних мостоподібних протезів з опорою на 34, 37, 44, 47 зуби

91. Батьки восьмирічного хлопчика скаржаться на припухлість та біль у ділянці лівої половини нижньої щелепи в дитини, підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно спостерігається: обличчя асиметричне через набряк тканин нижньощелепної ділянки ліворуч, у 74 зубі виявлено глибоку каріозну порожнину, перехідна складка згладжена та інфільтрована на рівні 73, 74, 75 зубів. Симптом флюктуації

позитивний, 74 зуб має II ступінь рухомості. Установіть клінічний діагноз.

- A. Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 74 зуба
- B. Загострення хронічного періодонтиту 74 зуба
- C. Гострий серозний періостит нижньої щелепи від 74 зуба
- D. Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 74 зуба
- E. Гострий періодонтит 74 зуба

92. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на погіршення фіксації часткового знімного пластинкового протеза, яким користується 1 рік. Об'єктивно спостерігається: альвеолярний відросток у беззубих ділянках атрофований, базис протеза відповідає протезному ложу, протез легко одягається та знімається. Яка тактика лікаря в цьому разі?

- A. Активація утримувальних кламерів
- B. Виготовлення нового протеза
- C. Зменшення базису протеза
- D. Виготовлення протеза з еластичною підкладкою

Перебазування протеза

93. Під час проведення припасовки каркаса металокерамічного мостоподібного протеза встановлено, що каркас контактує із зубами-антагоністами у положенні ЦО, доходить до уступів на опорних зубах, має товщину 0.3 мм. Яка тактика лікаря-стоматолога в цьому разі?

- A. Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток
- B. Відправити каркас на наступний лабораторний етап
- C. Зішліфувати металевий каркас у ділянках контакту із зубами-антагоністами
- D. Отримати відбиток зі встановленим каркасом
- E. Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза

94. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність припухлості в ділянці альвеолярного відростка верхньої щелепи з лівого боку, яку виявила випадково. Відкривання рота вільне. Об'єктивно спостерігається: у ділянці альвеолярного відростка верхньої щелепи ліворуч у проєкції коренів 22, 23 зубів деформація у вигляді округлого ущільнення, безболісного під час пальпації. 22, 23, 24 зуби інтактні. На рентгенограмі визначається ділянка

розрідження кісткової тканини з чіткими межами, розміром до 1 см в діаметрі, розташована між 22 і 23 зубами, періодонтальна щілина їх збережена, корені диверговані. ЕОД — у межах норми. Установіть попередній діагноз.

- A. Глобуломаксілярна кіста
- B. Амелобластома
- C. Фолікулярна кіста
- D. Носопіднебінна кіста
- E. Цементома

95. Чоловік віком 68 років скаржиться на появу два тижні тому виразки в порожнині рота, біль під час вживання їжі. Із анамнезу відомо: у пацієнта ІХС. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці щок праворуч у ділянці верхніх молярів виразка неправильної форми вкрита біло-сірим нальотом. У навколишніх тканинах відсутня запальна реакція слизової оболонки. Установіть попередній діагноз.

- A. Туберкульозна виразка
- B. Ракова виразка
- C. Декубітальна виразка
- D. Трофічна виразка
- E. Виразково-некротичний стоматит

96. Чоловік віком 70 років з повною відсутністю зубів на нижній щелепі звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Під час обстеження виявлено незначну та рівномірну атрофію альвеолярного відростка нижньої щелепи, точки прикріплення м'язів і складок слизової оболонки розташовані біля основи альвеолярного відростка. Укажіть тип атрофії беззубої нижньої щелепи в цього пацієнта.

- A. Перший тип за Келлером
- B. Третій тип за Келлером
- C. Четвертий тип за Келлером
- D. Другий тип за Оксманом
- E. Другий тип за Келлером

97. Під час профілактичного огляду п'ятирічного хлопчика лікар-стоматолог-ортодонт виявив у дитини інфантильний тип ковтання. Де розташований кінчик язика під час виконання функцій за умови цього типу ковтання?

- A. Між фронтальними зубами
- B. На межі твердого та м'якого піднебіння
- C. На альвеолярному відростку нижньої щелепи
- D. На дні порожнини рота
- E. У фронтальній ділянці твердого піднебіння

98. Пацієнту віком 18 років лікар-стоматолог встановив діагноз: гострий початковий карієс 22 зуба. Планується провести курс ремінералізувальної терапії. Які препарати найчастіше використовуються для цього методу лікування?

- A. Кальцію та фтору
- B. Калію та фосфору
- C. Фтору та стронцію
- D. Магнію та калію
- E. Хлору та натрію

99. Жінка віком 66 років у черзі на прийом до лікаря-стоматолога поскаржилася на погане самопочуття, з'явилися гострий стискальний біль за грудниною, задишка. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкіри обличчя, тони серця звучні, систолічний шум над аортою. ЧСС — 94/хв, АТ — 230/120 мм рт. ст. Який невідкладний стан розвинувся в пацієнтки?

- A. Гіпертонічний криз
- B. Анафілактичний шок
- C. Напад стенокардії
- D. Інфаркт міокарда
- E. набряк Квінке

100. З метою видалення пацієнту 36 зуба лікар-стоматолог виконав анестезію на нижній щелепі. При широко відкритому роті пацієнта укол голки було здійснено на 0,5 см нижче від жувальних поверхонь верхніх молярів у борозну між крило-нижньощелепною складкою та переднім краєм гілки нижньої щелепи на глибину 1,5 см. Яка анестезія була виконана?

- A. Торусальна за М.М. Вейсбремом
- B. Мандибулярна за Гоу-Гейтсом
- C. Мандибулярна за Вазирані-Акінозі
- D. Анестезія за П.М. Єгоровим
- E. Мандибулярна аподактильним методом

101. Пацієнту віком 42 роки показано видалення 46 зуба під місцевим знеболюванням. Укажіть положення лікаря-стоматолога стосовно пацієнта під час видалення цього зуба.

- A. Позаду та з правого боку
- B. Позаду
- C. Попереду
- D. Попереду та з лівого боку
- E. Позаду та з лівого боку

102. Пацієнт віком 49 років скаржиться на рухомість зубів нижньої щелепи праворуч та виділення гною з лунки видаленого 1,5 місяця тому 46 зуба. Об'єктивно спостерігається: у підщелепній ділянці з правого боку незначна

припухлість м'яких тканин, збільшені та слабкоболісні під час пальпації праві підщелепні лімфовузли. Альвеолярний відросток нижньої щелепи праворуч потовщений, рухомість 45 та 47 зубів I ступеня, по перехідній складці цієї ділянки виявлено норицю з випинанням грануляцій, якими також виповнена лунка видаленого 46 зуба. Який імовірний діагноз?

- A. Хронічний остеомієліт
- B. Гострий альвеоліт
- C. Еозинофільна гранульома
- D. Злоякісна пухлина
- E. Гострий остеомієліт

103. Чоловік віком 44 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: ясенні сосочки на верхній та нижній щелепах застійно гіперемовані, незначний набряк ясенного краю, мінералізовані та немінералізовані зубні відкладення. Яка проба підтвердить наявність пародонтальних кишень?

- A. Формалінова
- B. Глікогенова
- C. Бензидінова
- D. Вакуумна
- E. Роттера

104. Чотирнадцятирічна дівчинка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на сухість у роті, зменшення слиновиділення. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка порожнини рота матова, суха, з ділянками білуватих нашарувань, виявлено гіперкератоз вивідних проток слинних залоз. Шкіра обличчя бліда та шорстка, волосся сухе, нігті крихкі з поперечним посмугуванням. Недостатність якого вітаміну проявляється цими симптомами?

- A. A
- B. B2
- C. D3
- D. K
- E. B1

105. У восьмирічної дівчинки лікар-стоматолог діагностував гострий гнійний пульпіт 26 зуба. Який метод лікування доцільно застосувати в цьому разі?

- A. Вітальну екстирпацію
- B. Девітальну ампутацію
- C. Біологічний
- D. Вітальну ампутацію
- E. Девітальну екстирпацію

106. Військовослужбовець отримав уламкове поранення щелеп. Унаслідок потрапляння згустків крові на голосові зв'язки в пораненого розвинулися явища асфіксії. Яка це асфіксія?

- A. Аспіраційна
- B. Клапанна
- C. Обтураційна
- D. Стенотична
- E. Дислокаційна

107. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на випадіння пломби із зуба нижньої щелепи з правого боку, у якому раніше лікували карієс. Об'єктивно спостерігається: 45 зуб дещо змінений за кольором, на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою зуба. Зондування та перкусія безболісні. Термодіагностика негативна. На рентгенограмі виявлено рівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня 45 зуба. ЕОД — 110 мкА. Установіть діагноз.

- A. Хронічний фіброзний періодонтит
- B. Хронічний глибокий карієс
- C. Хронічний гранулюючий періодонтит
- D. Хронічний гангренозний пульпіт
- E. Хронічний фіброзний пульпіт

108. Що використовує лікар-стоматолог для переносу в артикулятор даних про положення верхньої щелепи відносно шарнірної вісі СНЩС?

- A. Лицьову дугу
- B. Оклюдатор
- C. Допоміжні відбитки
- D. Паралелометр
- E. Прикусні шаблони

109. Пацієнту віком 37 років зі звичним вивихом нижньої щелепи виготовляється незнімний апарат для обмеження відкривання рота. Який термін користування цим апаратом?

- A. 6-8 тижнів
- B. 1-2 тижні
- C. 6-12 місяців
- D. 3-4 тижні
- E. 4-5 років

110. Пацієнту для видалення 38 зуба лікар-стоматолог проводить знеболювання 4%-им розчином артикаїну. Яку максимальну дозу анестетика можна одноразово застосовувати?

- A. 500 мг
- B. 1000 мг
- C. 100 мг
- D. 200 мг
- E. 600 мг

111. Після проведеного обстеження пацієнту віком 34 роки встановлено діагноз: синдром Мелькерсона-Розенталя. Який симптомокомплекс характерний для цього синдрому?

- A. Макрохейліт, складчастий язик та парез лицевого нерва
- B. Червоний плоский лишай, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет
- C. Складчастий язик, атопічний хейліт та неврит трійчастого нерва
- D. Ромбоподібний глосит, екзематозний хейліт та парез лицевого нерва
- E. Зуби Гетчінсона, вроджена глухота, вроджена сліпота

112. Жінка віком 46 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен та неприємний запах із порожнини рота. Об'єктивно спостерігається: ясна набряклі, ціанотичні, пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм, м'які та тверді зубні нашарування, рухомість різців нижньої та верхньої щелеп I ступеня. Установлено діагноз: генералізований пародонтит I ступеня тяжкості, хронічний перебіг та складено план лікування. Які першочергові лікувальні заходи?

- A. Професійна гігієна порожнини рота
- B. Закритий кюретаж
- C. Загальна медикаментозна терапія
- D. Місцева медикаментозна терапія
- E. Шинування рухомих зубів

113. Чоловік віком 75 років скаржиться на безболісне новоутворення на обличчі, що з'явилося два місяці тому. Шкіра над ним виразковується та вкривається кіркою, яку пацієнт видаляє, але через короткий проміжок часу вона утворюється знову. Під час огляду на шкірі біля внутрішнього кута ока виявлено новоутворення у вигляді вузлика рожевого кольору з гладкою поверхнею розміром 0,6 см, укрите по центру кіркою. Навколо спостерігаються телеангіоектазії. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз?

- A. Базаліома
- B. Атерома
- C. Меланома

- D. Аденокарцинома
- E. Гемангіома

114. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: зубний ряд інтактний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість усіх зубів I ступеня. Яку шину найдоцільніше використати в цьому разі?

- A. Ельбрехта
- B. З екваторних коронок
- C. З повних коронок
- D. Мамлока
- E. Ковпачкову

115. Жінка віком 46 років скаржиться на наявність безболісного утворення грибоподібної форми, розміром 4 мм у діаметрі, що локалізоване в ділянці верхньої повіки та не відрізняється за кольором від навколишньої шкіри. Яке патологічне утворення, найімовірніше, виявлено у пацієнтки?

- A. Папілому
- B. Базаліому
- C. Атероми
- D. Шкірний ріг
- E. Кератоакантому

116. Хлопець віком 17 років скаржиться на головний біль, нудоту, біль у ділянці нижньої щелепи, її обмежену рухомість, деформацію обличчя, неможливість жування через травмування щойно в бійці. Установлено діагноз: перелом нижньої щелепи між 33 та 34 зубами. Визначається патологічна рухомість нижньої щелепи, утворилися великий та малий відламки. Яким буде типовий зсув відламків?

- A. Великий — донизу, малий — догори
- B. Великий — догори з поворотом зубів у бік язика, малий — донизу
- C. Великий — догори з поворотом зубів у бік щоки, малий — донизу
- D. Обидва відламки — догори
- E. Великий — догори, малий — донизу

117. Пацієнту віком 42 роки діагностовано амелобластому нижньої щелепи. Яке лікування показано застосувати в цьому разі?

- A. Резекцію нижньої щелепи із одномоментною остеопластикою
- B. Резекцію нижньої щелепи з променевою терапією
- C. Цистектомію
- D. Променеву терапію

- E. Екскохлеацію пухлини

118. У пацієнта після травми виявлено рухомість кісток носа, припухлість м'яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив у склеру лівого ока, симптом сходінки по нижньоорбітальному краю з обох сторін та в ділянці щелепно- виличних швів, носова кровотеча, відкритий прикус. Який перелом можна попередньо діагностувати?

- A. Верхньої щелепи за Лефор II
- B. Верхньої щелепи за Лефор III
- C. Кісток носа
- D. Верхньої щелепи за Лефор I
- E. Виличних кісток

119. Пацієнту віком 28 років з метою видалення 43 зуба лікар-стоматолог планує застосувати ментальну анестезію. Підборідний отвір на нижній щелепі у дорослих людей зазвичай розташований між 44 та 45 зубами. Як потрібно направити голку відносно до середньої лінії нижньої щелепи?

- A. Під кутом 45° ззаду наперед
- B. Горизонтально від різців у напрямку кута щелепи
- C. Вертикально згори донизу
- D. Під кутом 45° спереду до кута нижньої щелепи
- E. Під кутом 90° спереду назад

120. Чоловік віком 43 роки скаржиться на біль у нижньому зубі мудрості ліворуч, утруднене відкривання рота, болісне ковтання, погіршення загального стану, підвищення температури тіла до 39°C. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, відкривання рота та бічні рухи ліворуч значно обмежені, під час пальпації ділянки кута нижньої щелепи з лівого боку та позадущелепної ділянки пацієнт відчуває різкий біль. Крило-щелепна складка ліворуч гіперемована, набрякла. Який найімовірніший діагноз?

- A. Флегмона крило-щелепного простору
- B. Флегмона піднижньощелепного простору
- C. Флегмона навкологлоткового простору
- D. Флегмона підскроневої ділянки
- E. Абсцес щелепно-язикового жолобка

121. Дівчина віком 19 років скаржиться на множинні косметичні дефекти зубів верхньої та нижньої щелеп. Із анамнезу відомо, що плями були помічені вже під час прорізування зубів. Об'єктивно спостерігається: на всіх поверхнях

коронок зубів симетрично розташовані численні плями матового білого кольору, що не мають чітких контурів. Під час зондування поверхня плям гладка, емаль щільна, зондування безболісне. Метиленовим синім плями не зафарбовуються. Установіть діагноз.

- A. Ендемічний флюороз
- B. Гострий поверхневий карієс
- C. Ерозія емалі
- D. Місцева гіпоплазія емалі
- E. Гострий початковий карієс

122. До щелепно-лищевого відділення скеровано восьмирічну дівчинку зі скаргами на підвищення температури тіла до 39°C, асиметрію обличчя ліворуч. Об'єктивно спостерігається: набряк підщелепної ділянки, шкіра гіперемована, напружена, у складку не збирається, пальпація болісна, позитивний симптом флюктуації. Перехідна складка згладжена, гіперемована в ділянці 74, 75, 36 зубів. 75 зуб зруйнований на 2/3. Установлено діагноз: одонтогенна підщелепна флегмона ліворуч. Визначте місце проведення розтину флегмони.

- A. Паралельно до тіла внутрішнього краю нижньої щелепи, відступивши до середини 1,5 см
- B. Під кутом нижньої щелепи
- C. По серединній лінії дна порожнини рота
- D. По перехідній складці
- E. У підборідній ділянці над інфільтратом

123. Чоловіка віком 45 років шпиталізовано через виробничу травму лівої половини обличчя. З анамнезу відомо: пацієнт отримав травму близько 3-х годин тому, свідомість не втрачав. Об'єктивно спостерігається: у ділянці лівої щоки рана розміром 5х3 см неправильної форми з нерівними краями. При розведенні країв рани видно неушкоджені зуби. З боку порожнини рота — розрив слизової оболонки щоки. Прикус не порушений. Який вид хірургічної обробки рани треба провести в цьому разі?

- A. Первинну ранню
- B. Первинну відстрочену
- C. (не вказано)
- D. Первинну пізню
- E. Вторинну

124. Батьки семирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на виступання вперед верхніх передніх

зубів та звичку смоктати великий палець у дитини. Об'єктивно спостерігається: профіль обличчя помірно випуклий, губи змикаються з напруженням, верхні центральні різці нахилені вестибулярно, визначається сагітальна щілина 4 мм. Перші постійні моляри змикаються за I класом Енгля. Який апарат є найдоцільнішим для лікування цієї патології?

- A. Функціональний трейнер
- B. Пластинковий апарат із гвинтом
- C. Лицева дуга
- D. Брекет-система
- E. Апарат Брюкля

125. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхньої щелепи ліворуч, що з'явився 3 дні тому. Після огляду встановлено діагноз: загострення хронічного періодонтиту 26 зуба та показано його видалення. Виберіть інструментарій, необхідний для типового видалення 26 зуба.

- A. Синдесмотом, S-подібні ліві щипці, кюретажна ложка
- B. Синдесмотом, S-подібні щипці з гладкими щічками, що сходяться
- C. Прямий елеватор, багнетоподібні щипці зі щічками, що сходяться
- D. Синдесмотом, S-подібні праві щипці, кюретажна ложка
- E. Прямий елеватор, S-подібні щипці з гладкими щічками, що не сходяться

126. Пацієнту, якому виготовляють повний знімний пластинковий протез на верхню щелепу, проводять припасування індивідуальної ложки. Під час широкого відкривання рота індивідуальна ложка скидається з протезного ложа. Яку ділянку індивідуальної ложки треба вкоротити в цьому разі?

- A. По краю, який контактує з верхньощелепними горбами та місцем уявного розміщення молярів
- B. У ділянці щічних складок
- C. (не вказано)
- D. У фронтальному відділі
- E. По лінії «А»

127. Жінка віком 56 років під час стоматологічного прийому поскаржилася на тремор кінцівок та відчуття голоду. Після цього раптово з'явилося рухове збудження, яке перейшло в клонічні і тонічні судоми з втратою свідомості. Обличчя рясно вкрите потом, спостерігається тахікардія. Який стан найімовірніше виник у пацієнтки?

- A. Гіпоглікемічна кома
- B. Анафілактичний шок
- C. Гіперглікемічна кома
- D. Колапс
- E. Гіпертонічний криз

128. Чоловіку віком 53 роки показано виготовлення часткового знімного пластинкового протеза на верхню щелепу. Об'єктивно спостерігається: дефект зубного ряду IV класу за класифікацією Кеннеді, у фронтальній ділянці комірковий відросток нахилений вперед та добре виражений, укорочена верхня губа. Яку методику встановлення штучних зубів треба застосувати?

- A. Установлення зубів на приточці
- B. Перехресне встановлення зубів
- C. Установлення зубів на штучних яснах
- D. Зворотнє встановлення зубів
- E. Пряме встановлення зубів на штучних яснах

129. Пацієнтка віком 50 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект через просвічування та стоншення коронок передніх зубів. Під час об'єктивного обстеження виявлено підвищене стирання оральної поверхні різців на верхній щелепі та вестибулярної поверхні різців на нижній щелепі. Яка форма підвищеного стирання зубів спостерігається?

- A. Вертикальна
- B. Горизонтальна
- C. Генералізована
- D. Декомпенсована
- E. Змішана

130. Чоловік віком 31 рік скаржиться на біль у верхній щелепі, рухомість зубів верхньої щелепи. З анамнезу відомо, що періодично з'являються кров'яністі виділення з правої половини носа. Об'єктивно спостерігається: зуби верхньої щелепи з правого боку рухомі. На рентгенограмі виявлено гомогенне затемнення правої верхньощелепної пазухи, деструкція медіальної кісткової стінки у вигляді «розталого цукру». Який попередній діагноз?

- A. Рак верхньої щелепи
- B. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи
- C. Остеосаркома верхньої щелепи
- D. Амелобластома верхньої щелепи
- E. Специфічний верхньощелепний синусит

131. Чоловік віком 56 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість штучної коронки на 16 зубі, виготовленої рік

тому. Об'єктивно спостерігається: 16 зуб відновлено повною металевією штампованою коронкою, виявлено ознаки розцементування коронки та демінералізації дентину зуба. Що, найімовірніше, є причиною цього ускладнення?

- A. Нещільне охоплення коронкою шийки зуба
- B. Наявність міжзубних контактів
- C. Занурення краю коронки в ясенну борозну
- D. Супраконтат коронки із зубами-антагоністами
- E. Надмірний термін користування коронкою

132. Жінка віком 37 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на сильний пульсуючий біль у ділянці верхньої щелепи праворуч, підвищення температури тіла до 37,5°C. З анамнезу відомо: три дні тому пацієнтці видалено 17 зуб. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка в ділянці лунки видаленого 17 зуба набрякла, гіперемована, згусток зруйнований, лунка вкрита некротичним нальотом брудно-сірого кольору, у лунці наявний ексудат. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації. Установіть діагноз.

- A. Гострий гнійний альвеоліт
- B. Гострий серозний альвеоліт
- C. Луночкова кровотеча
- D. Перфорація гайморової пазухи
- E. Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

133. Чоловік віком 30 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодичну появу на слизовій оболонці порожнини рота поодиноких болючих виразок овальної форми. Під час огляду було виявлено на бічній поверхні язика ерозію овальної форми з плоским дном, розміром 5-6 мм, покриту білувато-жовтим нальотом та з гіперемованим обідком по периферії. Порожнина рота санована. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на холецистохолангіт. Який імовірний діагноз?

- A. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- B. Травматична виразка
- C. Первинний набутий сифіліс
- D. Рецидивний герпетичний стоматит
- E. Туберкульозна виразка

134. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на появу болючої виразки на язiku. Під час огляду лікар-стоматолог виявив на бічній поверхні язика ерозію з набряклими та гіперемованими краями та фібринозним нальотом на дні, а також глибоку каріозну

порожнину з гострими стінками в 47 зубі. Що визначатиме успіх лікування декубітальної ерозії язика в цьому разі?

- A. Усунення травмувального чинника
- B. Якнайшвидше застосування кератопластиків
- C. Збагачена вітамінами дієта
- D. Ретельна антисептична обробка слизової оболонки
- E. Раціональна гігієна ротової порожнини

135. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровоточивість ясен під час вживання їжі в дитини, неприємний запах із рота, підвищення температури тіла до 37,4°C. З анамнезу відомо: нещодавно хлопчик перехворів ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен яскраво гіперемована, легко кровоточить від дотику, верхівки ясенних сосочків вкриті сіруватим некротичним нальотом, після видалення якого оголюється виразкова поверхня. Велика кількість зубного нальоту. Який збудник цього захворювання?

- A. Анаеробна мікрофлора
- B. Вірус герпесу
- C. Стафілококи
- D. Стрептококи
- E. Дріжджоподібні гриби

136. Лікар-стоматолог готується до прийому пацієнта. Стоматологічна установка не обладнана сучасними пристроями для дезінфекції наконечників. Конструкція наконечника не передбачає автоклавування. Укажіть алгоритм дезінфекції наконечника.

- A. Дворазова обробка 70%-м спиртом або «Бацилолом АФ» з інтервалом 15 хв
- B. Дворазова обробка 70%-м спиртом або «Бацилолом АФ» з інтервалом 5 хв
- C. Дворазова обробка 6%-м розчином перекису водню та 70%-м спиртом з інтервалом 15 хв
- B. Дворазова обробка 6%-м розчином перекису водню з інтервалом 15 хв
- D. Одноразова обробка 70%-м спиртом або «Бацилолом АФ»

137. Пацієнту віком 35 років показано видалення 17 зуба через загострення хронічного періодонтиту. Яку анестезію треба застосувати в цьому разі?

- A. Туберальну та палатинальну
- B. Інфільтраційну

- C. Інфраорбітальну та різцеву
- D. Інтралігаментарну
- E. Інфраорбітальну та палатинальну

138. Чоловік віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль у зубі нижньої щелепи ліворуч від термічних та хімічних подразників. Під час огляду на жувальній поверхні 35 зуба виявлено каріозну порожнину в межах плащового розм'якшеного світлого дентину. Зондування по стінках болісне, термодіагностика позитивна, перкусія безболісна. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий середній карієс
- B. Хронічний глибокий карієс
- C. Хронічний середній карієс
- D. Гострий глибокий карієс
- E. Гіперемія пульпи

139. Яку концентрацію розчину артикаїну використовують для інфраорбітальної анестезії?

- A. 4%
- B. 5%
- C. 1%
- D. 10%
- E. 2%

140. До лікаря-стоматолога звернулася дівчина віком 16 років зі скаргами на наявність білих плям на деяких зубах верхньої та нижньої щелеп. Суб'єктивні відчуття відсутні. Об'єктивно спостерігається: на вестибулярних поверхнях 14, 24, 34, 44 зубів білі матові плями з чіткими межами, розташовані симетрично. Під час зондування поверхня емалі гладка. Який попередній діагноз?

- A. Флюороз
- B. Гострий початковий карієс
- C. Системна гіпоплазія емалі
- D. Місцева гіпоплазія емалі
- E. Недосконалий амелогенез

141. Під час огляду п'ятирічної дівчинки лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину на жувальній поверхні 74 зуба в межах світлого та розм'якшеного плащового дентину. Зондування емалево-дентинної межі чутливе. Реакція на холодний подразник болісна, швидко минає після його усунення. Дитина з підвищеною нервовою збудливістю. Для лікування карієсу вибрана ART- методика. Який пломбувальний матеріал доцільно застосувати в цьому разі?

- A. Склоіономерний цемент
- B. Композиційний матеріал

- С. Силікофосфатний цемент
- Д. Цинкфосфатний цемент
- Е. Гідроксидкальційумісну пасту

142. Оглядаючи пацієнта віком 30 років, лікар-стоматолог виявив невеликі яскраво-червоні висипання на крилах носа та губах у вигляді телеангіоектазій, що виступають над поверхнею шкіри і під час натискання бліднуть. З анамнезу відомо: такі ж висипання були у батька пацієнта. Подібні висипання також локалізуються на піднебінні. У загальному аналізі крові та коагулограмі патологічних змін не виявлено. Яка, імовірно, патологія в пацієнта?

- А. Хвороба Рандю-Ослера
- В. Гострий лімфобластний лейкоз
- С. Хвороба Верльгофа
- Д. Хвороба Віллебранда
- Е. Гемофілія В

143. Чоловіку віком 43 роки показано видалення 46 зуба через загострення хронічного періодонтиту. Коронкова частина зуба збережена. Які щипці треба застосувати для видалення в цьому разі?

- А. Дзьобоподібні з шипами на щічках
- В. S-подібні праві
- С. Дзьобоподібні щипці зі щічками, що не сходяться
- Д. Дзьобоподібні щипці зі щічками, що сходяться
- Е. Багнетоподібні коронкові

144. Жінка віком 24 роки, яка перебуває на 26-му тижні вагітності, звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на збільшення розміру ясенних сосочків у ділянці фронтальних зубів. Об'єктивно спостерігається: ясенні сосочки верхньої та нижньої щелеп гіперемовані, набряклі, кровоточать від дотику, у фронтальній ділянці перекривають коронки зубів на 1/2 висоти. Зміна функціонування якої системи проявляється цими симптомами в пацієнтки?

- А. Ендокринної
- В. Серцево-судинної
- С. Центральної нервової
- Д. Імунної
- Е. Травної

145. Які протипоказання до застосування рідкотекучих композитів у стоматологічній практиці?

- А. Пломбування каріозних порожнин IV класу за Блекум

- В. Неінвазивне закриття фісур
- С. Створення «амортизаційної» прокладки під реставрацією на жувальних зубах
- Д. Інвазивне закриття фісур
- Е. Пломбування невеликих пришийкових порожнин

146. Пацієнтці виготовляється металокерамічний мостоподібний протез через відсутність 16 зуба. Який клінічний етап є наступним після примірки та корекції металевих каркаса протеза?

- А. Примірка металокерамічного мостоподібного протеза на опорних зубах та корекція оклюзійних співвідношень
- В. Фіксація центрального співвідношення щелеп
- С. Глазурування поверхні металокерамічного мостоподібного протеза
- Д. Зняття анатомічного відбитка
- Е. Фіксація металокерамічного мостоподібного протеза

147. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на безболісну припухлість у ділянці нижньої щелепи праворуч, що з'явилася 6 місяців тому і повільно збільшується у розмірах. Об'єктивно спостерігається: на тілі нижньої щелепи праворуч у ділянці 45, 46 зубів горбкувате потовщення кістки розміром 2x1,5 см, щільне та безболісне під час пальпації. Шкірні покриви та слизова оболонка над ним у кольорі не змінені, рухомі. Порожнина рота санована. Зуби на нижній щелепі інтактні. Чутливість нижньої губи не змінена. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Під час рентгенологічного обстеження виявлено полікістозне утворення в ділянці тіла нижньої щелепи праворуч із чіткими межами. Який попередній діагноз?

- А. Амелобластома
- В. Фолікулярна кіста
- С. Остеосаркома
- Д. Одонтогенна фіброма
- Е. Одонтома

148. Чоловік віком 60 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігається: відсутні 14, 15, 16, 17 зуби. Планується відновити дефект верхнього зубного ряду металокерамічним протезом з опорою на імплантати. У процесі лікування виготовляються оклюзійно-хірургічні шаблони. На якому етапі лікування вони застосовуються?

- А. Установки імплантатів
- В. Вибіркового пришліфовування

- С.** Оклюзійної корекції
- Д.** Фіксації супраконструкції
- Е.** Установки абатментів

149. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість передніх зубів нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: різці нижньої щелепи інтактні, мають рухомість І ступеня, ікла та бічні зуби стійкі. На ортопантограмі виявлено резорбцію міжальвеолярних перегородок у ділянці різців на 1/4 висоти. Між передніми зубами є діастема та тріска розміром до 1 мм. Планується тимчасове шинкування. Яку шинуючу конструкцію доцільно застосувати в цьому разі?

- А.** Скловолоконну
- В.** Із пластмасових коронок
- С.** Інтрадентальну
- Д.** Із напівкоронок
- Е.** Ковпачкову

150. Дитину в ділянці верхньої губи вкусила домашня собака. Яку допомогу необхідно надати насамперед?

- А.** Промити рану водою з 10%-им розчином господарського мила
- В.** Накласти стерильну марлеву серветку
- С.** Накласти джгут
- Д.** Увести протиправцеву сироватку
- Е.** Увести знеболювальний розчин